

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	噁心、嘔吐 Nausea、Vomit				
編號	A31000-Q03-W-001	制定者	N16 蔡富卿	公布日期	99 年 01 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 3.9 版/5 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員能瞭解噁心、嘔吐的定義、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

噁心：為一種想吐，但是沒有吐的動作，發生在喉頭後的一種主觀或不舒適的感覺。

嘔吐：為一種自發突然的動作，指猛烈的經口吐出胃或十二指腸的內容物。

1. 清晨嘔吐：可能是懷孕、胃炎、飲酒過多或新陳代謝障礙造成。
2. 進食後嘔吐：可能為胃或十二指腸疾病。
3. 嘔吐物含大量血液成分，可能為上腸胃道出血、嚴重食道炎、食道靜脈破裂或抗凝血劑中毒；嘔吐物含有膽汁且有糞便味可能是腸阻塞。
4. 幽門阻塞會產生嚴重噴射狀嘔吐，且嘔吐物不含膽汁。

噁心嘔吐的型態，可分為預期性嘔吐、急性嘔吐和延遲性嘔吐。預期性嘔吐，可發生在一個化學治療療程或多次療程結束後；急性嘔吐是化學藥物注射後二至八小時產生的，可持續約一天，特別是接受Cisplatin、DTIC、Adramycin、Bleomycin、Pharmorubicin、Vincristine治療，及未接受足夠止吐劑治療的病人，發生在第二至第五天為延遲性嘔吐，若能控制急性及延遲性嘔吐可減少預期性嘔吐的發生。

主題名稱	噁心、嘔吐	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-O01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/5

化學治療是目前治療惡性腫瘤的主要方法之一，研究指出，在化學治療期間有80至90%病人會出現噁心嘔吐不適症狀。當噁心嘔吐症狀無法緩解時，不僅病人心理壓力增加，影響生活品質，甚至會降低對化學治療的順從性與配合度，危及病人健康。所以我們遇到病人出現噁心嘔吐的情形時，應先評估其型態與頻率，再決定是否給予藥物或非藥物治療。

(二) 常見治療

1. 藥物治療

目前對化學治療後產生的噁心嘔吐，效果最好的是作用在血清素第三型(5-HT₃)接受器的拮抗劑，例如：gasnisetron(Kytril)和ondansetron(Zofran)(0.15mg/kg)，通常在化學治療前30分鐘給予，可緩解60-70%病人急性期的噁心嘔吐，另外合併口服或靜脈注射Dexamethasone(10mcg/kg)。其他在延遲性嘔吐上可以使用口服或靜脈注射給予，或使用Lorazepam 0.05mg/kg，每12小時靜脈注射給予。常見化學治療藥物副作用評估表見附件一CS 05-15。

2. 非藥物治療

(1) 飲食治療：

- A. 化學藥物治療前 4-6 小時，儘量減少食物及水份的攝取。
- B. 喝少量清流質飲食，直到噁心、嘔吐症狀停止。
- C. 準備之食物需接近室溫或放涼，因太熱食物會激起噁心感。
- D. 高熱量食物可增加體力還可降低噁心感，如：冰淇淋、蛋糕、起司。
- E. 嘔吐多次易造成體液電解質不平衡，可給予稀釋的運動飲料或靜脈輸液，補充水份及電解質。
- F. 避免吃太辣、太甜、油膩或油炸的食物。
- G. 保持口腔清潔。

(2) 放鬆技巧：

- A. 規律性呼吸：利用注意力集中於人體自然的規律呼吸上而達到放鬆的效果，可合併靜坐、瑜珈或冥想。

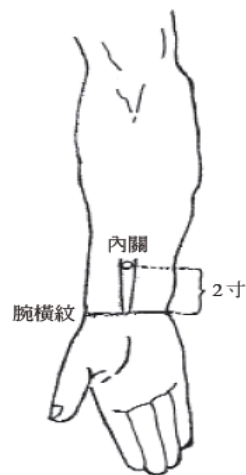
主題名稱	噁心、嘔吐	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-O01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/5

B. 漸進式肌肉放鬆：利用漸進式的訓練肌肉群來指導病人的肌肉放鬆與緊張。

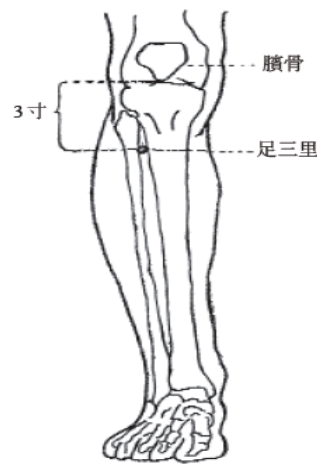
C. 引導式冥想：讓病人透過聽覺與視覺集中注意力於自己的想像空間。

(3) 中醫治療：

A. 針灸：採輕柔緩慢之手法於內關穴（手腕橫上 2 吋）、足三里（小腿外側，髕骨下緣 3 吋）刺激按摩，可配合潤滑油使用見（圖一）、（圖二）。



圖一 內關穴位圖



圖二 足三里穴位圖

B. 藥草：如生薑或薑類製品。

(三) 護理問題

1. 體液容積缺乏／與嘔吐、腹瀉有關。

(四) 護理措施

1. 體液容積缺乏／與嘔吐、腹瀉有關

(1) 觀察病人的嘔吐情形，評估有無代謝性鹼中毒及電解質不平衡，特別是鉀、氫、及氯化物。

(2) 每日記錄輸入輸出量，特別在有嘔吐時。

(3) 依醫囑給與靜脈輸液的補充，並監測生命徵象及電解質變化。

(4) 若症狀改善，先給予病人清流質飲食，並觀察病人由口進食後的耐受情形。當進食後無出現噁心嘔吐現象後，則可進食軟質食物，再改為固體食物

主題名稱	噁心、嘔吐	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-O01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/5

(五) 衛教指導

1. 飲食

若症狀改善，可先喝少量清流質飲食。準備之食物需接近室溫或放涼，因太熱食物會激起噁心感。也可以適時的攝取冷質食物，例如：冰淇淋、蛋糕、起司，除了可以降低噁心感，還可以增加熱量補充。若出現多次嘔吐情形，除了依醫囑給與靜脈輸液維持體液電解質平衡，也可以給予稀釋的運動飲料或靜脈輸液，補充水份及電解質。

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 王桂芸、馮容芬、李惠玲、谷幼雄、周桂如、高啟雯、陳麗華、詹恩愉、歐嘉美、王鳳雲、王麗雲、白玉珠、林小玲、幸生、明金蓮、尚忠菁、林春只、周碧玲、林麗秋...蕭淑貞(2022)。新編內外科護理學(上冊，六版)。永大書局，頁 12-14~12-15。
- (二) 楊家豪、曾淑卿(2024)。頭頸癌常見化療藥物及副作用之照護。彰化護理，31(3)，6-12。
- (三) 施美玲、寇蕙蓀、許麗玉、陳孟君(2022)。穴位按壓對緩解接受化學治療乳癌病人急性與延遲性噁心嘔吐影響之系統性文獻回顧與臨床應用。腫瘤護理雜誌，22(2)，21-33。

主題名稱	噁心、嘔吐	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-O01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/5

七、附件

(略)